



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : مني علي دياب علي

العنوان : ش عمر بن الخطاب -
ش صهاريج المياه

المحافظة : المنوفية

تاريخ تسجيل الإستمارة : 07-10-2026

رقم البطاقة : 27803181700421 رقم التليفون : 01113639672

العمر (تاريخ الميلاد) : 18-03-1978 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك الإخصائي الاجتماعي التوقيع: (-----) المقر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مسح ذري علي العظام [12966] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة. تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.
تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: منى علي دياب علي National ID: 27803181700421	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Bone scintigraphy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



منى
على دياب على
ش عمر بن الخطاب - ش صهاريج المياه
الوراق - الجيزة

١٩٧٨/٠١/٠٨ ٢٧٨٠٣١٨١٧٠٠٤٢١

IE3077245

١١١٢٦٢٩٦٧٢

٩/٧

٩/٧

٢٠١٩/١٠ ٢٧٨٠٣١٨١٧٠٠٤٢١

رؤية منزل

أنثى مسلمة أرملة

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٦/٠٩/٣٠ ١



اسم المريض بالإنجليزية: Mona Ali Diab	كود المريض: 99080
تاريخ التقرير: 2026/09/07 10:53:47 AM	السن: ٤٨ سنة ٥ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral full field Digital Mammography

Clinical summary: right breast lump .

Technique

Medio-lateral oblique and CC views & High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR B)
- UOQ spiculated heterogenous dense lesion, seen about 6 cm from the nipple, complementary ultrasound showed irregular spiculated hypoechoic mass lesion seen at 9:10 o'clock measures about 3.3x2cm , and about 1.3cm from the overlying skin
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Two indeterminate axillary lymph nodes (level I) with focal increased cortical thickness reaching 4 mm .

Left breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR B)
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

Right breast (BIRADS 4c): UOQ suspicious mass lesion with ipsilateral indeterminate axillary LNs (level I) for Tru cut biopsy and histopathological correlation

Left breast (BI-RADS 1) : normal study .

Best regards,
Dr. Sara Gamal, MSc

جمهورية الكويت
بطاقة تحقيق الشخصية

منى
على دياب على
بن عشرين القطيف - بن صهاريج البيه
الوراق - الجزيرة

٢٧٨٠٣١٨١٧٠٠٤٢١

٢٧٨٠٣١٨١٧٠٠٤٢١

IE3077245

الرقم ١١١٤٦٢٩٦٧٥
٥٤٩٩١٥٤
٩١٨
الرقم معلقه → ١١٥٦٦٠٦١٢٥

٢٠١٩/١٠ ٢٧٨٠٣١٨١٧٠٠٤٢١
رقة منزل
أش
منطقة
أرملة
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٦/٩/٣٠

١

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الادارة المركزية لتنظيم المعلومات والتحول
الرقمي

رسم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار: 2026-9-8

جهة الاصدار: فرع الجيزة

الى من يهمه الامر.....

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي " وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

السيد (ة) منى على دياب بطاقة رقم 27803181700421
تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون اننى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعه: 2026-9-8

قادة مركز نظم المعلومات
يعتقد،،،،،

مسلم 2071907



الخطاب سدى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاصدار الا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية او
وزارة التضامن الاجتماعى او وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لتنظيم المعلومات والتحول الرقعى

اسم المريض بالإنجليزية: Mona Ali Diab	كود المريض: 99080
تاريخ التقرير: 2026/09/07 10:53:47 AM	السن: ٢٨ سنة ٥ شهر

Women's Health Outreach Program
Bilateral full field Digital Mammography

Clinical summary: right breast lump .

Technique

Medio-lateral oblique and CC views & High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR B)
- UOQ spiculated heterogenous dense lesion, seen about 6 cm from the nipple, complementary ultrasound showed irregular spiculated hypoechoic mass lesion seen at 9:10 o'clock measures about 3.3x2cm , and about 1.3cm from the overlying skin
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Two indeterminate axillary lymph nodes (level I) with focal increased cortical thickness reaching 4 mm .

Left breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR B)
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

Right breast (BIRADS 4c): UOQ suspicious mass lesion with ipsilateral indeterminate axillary LNs (level I) for Tru cut biopsy and histopathological correlation

Left breast (BI-RADS 1) : normal study .

Best regards,
Dr. Sara Gamal, MSc



NH&MRI

قسم الباثولوجي

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: مني علي دياب علي	Age: 48years	Sex: female
Request type: مباره	Sub request type:	
Hospital no:	Pathology no.: 947-2026	
Department: صحه مرآه	Date of result: 19/9/2026	
Referred by: د/إيمان عادل	Date of biopsy: 8/9/2026	
Nature of specimen: tru-cut biopsy	I.D. Number: 27803181700421	

Clinical diagnosis: Right breast mass

Gross pathology :

Multiple fragmented grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: ER- PR- Her2- KI67

Microscopic picture:

Section examined revealed core of tumor showing invasive duct carcinoma of no special type (NST). The tumor forms nests, tubule and cribriform pattern infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing marked anaplasia and poor tendency to form tubules. There is moderate number of mitotic figures.

Immunohistochemical Result

ER: Weak nuclear staining in >10% of tumor cells (Allred Score 3/8).

PR: Weak nuclear staining in >10% of tumor cells (Allred Score 3/8).

Her2: Strong complete membranous staining in >10% of tumor cells (score 3+) positive.

Ki67: Positive nuclear staining of 60% of tumor cells.

Diagnosis: Right breast mass ,Tru-cut biopsy :

Invasive duct carcinoma (NST), Grade III.

Comment: according to cap guide line (2020) the cancer in the sample has low level (1-10%) of estrogen receptor (ER) expression by IHC. There are limited data on the overall benefits of hormonal therapy for patients with low level (1-10%) ER expression but they currently suggest possible benefit, so patient are considered eligible for hormonal treatment there are data suggesting that cancer with these results are heterogeneous in both behavior and biology often have gene expression profile more sensitive to ER negative cancer

Signature:

Dr. Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D